

Ile trwa *terapia NPD*?

Skuteczna terapia: 2–5 lat (Caligor 2015). Pierwsze efekty objawowe po 6–12 miesiącach. Zmiana strukturalna po 2–5 latach. Krótka terapia daje objawową poprawę, nie strukturalną.

CZAS: 10 min Wersja edukacyjna **ŹRÓDŁO:** Caligor (2015); Ronningstam (2012, 2023); Behary (2013)

JAK UŻYWAĆ

1 · Poznasz cztery fazy terapii NPD (sekcja 01) — alians → samokontrola → rdzeń → integracja. **2** · Zrozumiesz *realistyczny timeline* efektów: kiedy czego się spodziewać (sekcja 02). **3** · Poznasz cztery powody, dlaczego terapia NPD jest *trudna* (sekcja 03). **4** · Zobaczysz, dlaczego **stabilność** (jeden terapeuta, regularność) jest ważniejsza niż „świećność” (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Caligor, Kernberg & Clarkin (2015) w *Psychodynamic Therapy for Personality Pathology* oszacowali typowy czas skutecznej terapii NPD na **2–5 lat**, z możliwością dłuższego trwania w bardziej złożonych przypadkach. Ronningstam (2023): brak długoterminowych danych prospektywnych porównywalnych z BPD (Zanarini i wsp.), ale rokowanie jest **gorsze** — ze względu na *ego-syntoniczność* objawów („to inni mają problem”), wysokie współwystępowanie z depresją, uzależnieniami i ASPD oraz *wysoki dropout* (50–70% w pierwszych 6 miesiącach). NPD jest, obok zaburzenia antyspołecznego (ASPD), **jednym z najtrudniejszych** zaburzeń osobowości do leczenia (Ronningstam 2012). *Przyczyny*: niska motywacja (pacjent przychodzi „z problemem zewnętrznym” — rozwód, kryzys zawodowy, depresja — rzadko z motywacją wewnętrzną), trudny sojusz terapeutyczny (oscylacja idealizacja-dewaluacja terapeuty), nietolerancja konfrontacji, wstyd jako bariera. **Ale**: zmiana **jest możliwa**. Bamelis i wsp. (2014, RCT): terapia schematów osiąga remisję u około 70% pacjentów po 50 sesjach. Modele długoterminowe — *Transference-Focused Psychotherapy* (TFP, Kernberg), terapia schematów (Young), *Mentalization-Based Treatment* (MBT, Fonagy) — wszystkie wymagają lat. Mechanizm zmiany: *internalizacja nowego doświadczenia relacyjnego* przez setki powtórzeń cyklu zerwanie-naprawa w aliansie. To proces powolny, wymagający stabilności. **Konsekwencja kliniczna**: psychoedukacja o czasie trwania *na początku* jest jedną z najważniejszych interwencji — pacjent oczekuje szybkiej zmiany, po 10–20 sesjach dewaluuje terapeutę i odchodzi.

01

Cztery fazy terapii — co dzieje się kiedy

FAZA 1 · ALIANS

3–6 miesięcy

Budowanie przymierza. Pacjent *testuje* terapeutę. Bez konfrontacji, bez interpretacji. Terapeuta = *limited reparenting* — ciepły, walidujący „rodzic”. Cel: pacjent czuje się bezpiecznie.

FAZA 2 · SAMOKONTROLA

6–18 miesięcy

Delikatna konfrontacja fasady. Empatyczna konfrontacja (Behary 2008). Praca z roszczeniowością, impulsywnością. Pacjent *opiera się*. Pierwsze widoczne zmiany behawioralne.

FAZA 3 · RDZEŃ

1–3 lata

Dotarcie do *Samotnego Dziecka*. Imagery *rescripting* (Arntz 1999) wczesnych scen wstydu. Praca z rdzennym poczuciem siebie. Model *Narzędzi Terapeutycznych* · **OSOBOWOŚĆ NARCYSTYCZNA** · **LINEART V2**

FAZA 4 · INTEGRACJA

ciągła

Wzmocnienie trybu *Zdrowy Dorosły*. Autentyczne relacje. Profilaktyka nawrotów. **Nawroty są oczekiwane** — w sobie powrót do fasady jest normalny, nie porażka.

02 Realistyczny timeline efektów



Pacjent oczekuje zmiany w 10 sesjach. Po 20 sesjach rozczarowuje się brakiem dramatycznej poprawy, dewaluuje terapeutę („nie pomaga”) i odchodzi. Cykl powtarza się z różnymi terapeutami przez lata — bez efektu. Realistyczna psychoedukacja *na samym początku* ratuje terapię: „pierwsze efekty objawowe po 6–12 miesiącach, zmiana strukturalna po 2–5 latach. Czy gotowy/-a jesteś na tę inwestycję?”

03 Cztery powody trudności terapii NPD

1 · NISKA MOTYWACJA

Pacjent *rzadko* przychodzi „ze sobą”. Przychodzi z **depresją**, rozwodem, kryzysem zawodowym, wypaleniem. Problem widzi w innych. Bez przepracowania tej fazy — dropout.

2 · WYSOKIE RYZYKO DROPOUT

50-70% pacjentów rezygnuje w pierwszych 6 miesiącach. Powód: nietolerancja konfrontacji, wolne tempo, brak natychmiastowych efektów, dewaluacja terapeuty po pierwszym rozczarowaniu.

3 · TRUDNY SOJUSZ

Oscylacja *idealizacja-dewaluacja terapeuty*. Najpierw „najlepszy terapeuta świata”, potem „beznadziejny, niczego nie rozumie”. Każda dewaluacja to test, czy terapeuta wytrwa.

4 · WSTYD JAKO BARIERA

Praca z rdzeniem aktywuje wstyd nie do zniesienia. Pacjent *natychmiast* przykrywa go fasadą. Trzeba *setek* małych otwarć i powrotów, by stopniowo tolerować ten obszar.

04 Stabilność jest ważniejsza niż „świąteczność”

CO NIE DZIAŁA

Pięciu „świątecznych” terapeutów po roku każdy. Pacjent zaczyna od zera za każdym razem — nowe testowanie, nowe budowanie aliansu, nowa dewaluacja po pierwszym rozczarowaniu. **Brak internalizacji.**

CO DZIAŁA

Jeden „średni” terapeuta przez 5 lat. Setki powtórzeń cyklu *zerwanie-naprawa* w aliansie. Tylko w **stabilnej** relacji buduje się nowa ścieżka neuronalna — to wymaga *czasu i powtórzeń*, nie wybitności.

Klucz: terapia NPD to *maraton*, nie sprint. Pacjent oczekujący „naprawy” w 10 sesjach będzie rozczarowany. Terapeuta oczekujący szybkich postępów wypali się. **Psychoedukacja o czasie trwania na samym początku** jest jedną z najważniejszych interwencji — pozwala pacjentowi *zaakceptować lub odrzucić* proces świadomie. Lepiej ujawnić to wcześniej niż po roku frustracji. Zmiana strukturalna wymaga *internalizacji nowego doświadczenia relacyjnego* przez setki powtórzeń (Caligor 2015). Konieczna stabilność — ten sam terapeuta, ten sam gabinet, regularne sesje. Bamelis 2014 (RCT): terapia schematów osiąga remisję u około 70% pacjentów po 50 sesjach. To *najlepszy* dostępny wynik dla NPD.